

CAPÍTULO 14.33

Enfermedad de Behçet

PERFIL EUNACOM 1.05.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **enfermedad de Behçet** es una patología multisistémica de carácter crónico y etiología autoinmune. Aunque se clasifica dentro de las **vasculitis** (específicamente de vasos de calibre variable), sus manifestaciones clínicas a menudo presentan solapamiento con las **Espondiloartropatías Seronegativas**, lo que requiere un alto índice de sospecha clínica para su diagnóstico.

Definición y Generalidades

Se define como una vasculitis sistémica que puede afectar vasos de cualquier tamaño (pequeño, mediano o grande) tanto en el territorio arterial como venoso. Es especialmente frecuente en poblaciones de la "Ruta de la Seda" (desde el Mediterráneo hasta el este de Asia), aunque en Chile se presentan casos esporádicos que deben ser correctamente identificados.

Cuadro Clínico: Los Pilares Diagnósticos

La presentación clínica es la clave para el diagnóstico, destacando la afectación de mucosas como el signo cardinal.

1. Úlceras Orales

- Son la manifestación más frecuente (presentes en casi el 100% de los pacientes). - **Características:** Son habitualmente **dolorosas**, recurrentes, de forma redondeada u ovalada, con bordes bien definidos y fondo eritematoso o necrótico. - Aparecen en brotes y suelen curar sin dejar cicatriz.

2. Úlceras Genitales

- Son el segundo síntoma más importante y altamente sugerente. - **Características:** Al igual que las orales, son **dolorosas**. - A diferencia de las orales, estas úlceras **suelen dejar cicatriz** al sanar, lo cual es un hallazgo clínico valioso durante el examen físico.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferencial de Oro para el EUNACOM: 1. Behçet vs. Lupus Eritematoso Sistémico: Las úlceras orales del Behçet son **dolorosas**, mientras que las del Lupus suelen ser indoloras. **2. Behçet vs. Sífilis:** El chancro sífilítico es una úlcera **indolora**, a diferencia de la úlcera genital del Behçet que es muy dolorosa.

3. Manifestaciones Cutáneas y el Fenómeno de Patergia

Además de las úlceras, los pacientes pueden presentar: - **Eritema Nodoso:** Nódulos subcutáneos dolorosos, generalmente en extremidades inferiores. - **Pseudo-foliculitis** o lesiones acneiformes. - **Fenómeno de Patergia:** Es una reacción de hipersensibilidad cutánea inespecífica.

NOTA CLÍNICA

Patofisiología del Fenómeno de Patergia: Consiste en la formación de una pústula o pápula eritematosa ante un traumatismo mínimo en la piel. En la práctica clínica, se evalúa inyectando una pequeña cantidad de suero fisiológico o simplemente pinchando la piel con una aguja estéril. Si a las 24-48 horas aparece una pústula en el sitio de la punción, el fenómeno se considera **positivo**, lo cual orienta fuertemente al diagnóstico de Behçet.

4. Otras Manifestaciones Sistémicas

Como buena vasculitis, el Behçet puede afectar múltiples órganos: - **Articulares:** Artritis no erosiva (similar a las espondiloartropatías). - **Oculares:** **Uveítis** posterior o anterior (hipopión), que puede comprometer seriamente la visión. - **Neurológicas (Neuro-Behçet):** Afectación del Sistema Nervioso Central o periférico. - **Vasculares:** Trombosis venosas profundas, aneurismas arteriales. - **Renales:** Glomerulonefritis (menos frecuente que en otras vasculitis).

Diagnóstico Diferencial

Es fundamental distinguir el Behçet de otras patologías que cursan con úlceras o compromiso sistémico:

TABLA 14.33.1: CARACTERÍSTICA VS ENFERMEDAD DE BEHÇET			
CARACTERÍSTICA	ENFERMEDAD DE BEHÇET	LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO	SÍFILIS (CHANCRO)
Dolor en úlceras	Muy dolorosas	Generalmente indoloras	Indolora
Localización	Oral y Genital	Principalmente Oral	Genital (fase primaria)
Patergia	Positivo	Negativo	Negativo
Marcadores	Clínico (Sin marcador específico)	ANA (+), Anti-dsDNA	VDRL / FTABS (+)

Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad de Behçet es **eminentemente clínico**. No existe un examen de laboratorio o marcador serológico patognomónico (específico). - Se basa en la presencia de úlceras orales recurrentes asociadas a otros criterios (úlceras genitales, lesiones oculares, lesiones cutáneas o prueba de patergia positiva).

Manejo y Tratamiento

El tratamiento se ajusta según la gravedad y los órganos comprometidos.

- **Cuadros Mucocutáneos Leves:**
 - Si el paciente solo presenta úlceras sin afectación de otros órganos, el fármaco de elección es la **Colchicina**.
 - La colchicina ayuda a disminuir la frecuencia y severidad de los brotes de úlceras orales y genitales.
- **Cuadros Moderados a Graves:**
 - **Corticoides:** Para el manejo de brotes agudos y compromiso sistémico.
 - **Ahorrradores de corticoides:** Inmunosupresores como Azatioprina o Ciclosporina (especialmente en compromiso ocular).
- **Casos Refractarios:**
 - Terapias biológicas (como anti-TNF) representan la última línea de tratamiento en casos graves o que no responden a terapia convencional.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El manejo de la enfermedad de Behçet, especialmente cuando hay compromiso ocular o neurológico, debe ser realizado por un especialista (Reumatólogo). La detección precoz de la **Uveítis** es crítica para evitar la ceguera permanente.

Resumen de Perlas EUNACOM

- **Úlceras orales + genitales dolorosas** = Sospecha de Behçet. - **Fenómeno de Patergia:** Aparición de pústula tras pinchazo estéril. - **Tratamiento inicial de úlceras:** Colchicina. - **Asociación:** Se comporta como vasculitis pero tiene rasgos de espondiloartropatía.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente con úlceras orales dolorosas recurrentes, úlceras genitales dolorosas y formación de pústula tras inyección de suero fisiológico en la piel. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedad de Behçet. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Síntomas cardinales: úlceras orales dolorosas + úlceras genitales dolorosas
- Úlceras orales dolorosas (vs lupus: indoloras); úlceras genitales dolorosas (vs sífilis: indoloro)
- Fenómeno de patergia: formación de pústula ante mínimo traumatismo cutáneo; orienta fuertemente al diagnóstico
- Diagnóstico clínico; no hay marcador específico
- Tratamiento leve: colchicina; grave: corticoides + ahorradores; última línea: biológicos
- Como vasculitis puede afectar SNC, SNP y riñones

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDAD DE BEHÇET)**PREGUNTA 1**

Paciente con úlceras orales dolorosas recurrentes, úlceras genitales dolorosas y formación de pústula tras inyección de suero fisiológico en la piel. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Lupus eritematoso sistémico
- B)** Sífilis primaria
- C)** Enfermedad de Behçet
- D)** Artritis reactiva
- E)** Herpes genital

PREGUNTA 2

¿Qué diferencia las úlceras orales de la enfermedad de Behçet de las del lupus?

- A)** Las de Behçet son indoloras y las del lupus dolorosas
- B)** Las de Behçet son dolorosas y las del lupus indoloras
- C)** No hay diferencia
- D)** Las de Behçet son vesiculares
- E)** Las del lupus son más frecuentes

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Behçet cuando solo presenta úlceras sin afectación de otros órganos?

- A)** Corticoides en dosis altas
- B)** Metotrexato
- C)** Colchicina
- D)** Ciclofosfamida
- E)** Rituximab

RESUMEN: ENFERMEDAD DE BEHÇET

La enfermedad de Behçet es una vasculitis cuyas manifestaciones recuerdan a las pelvispondiloartropatías. Los dos síntomas más importantes son las úlceras orales dolorosas (a diferencia de las del lupus que son indoloras) y las úlceras genitales dolorosas (a diferencia del chancro de la sífilis que es indoloro). Además puede presentar artritis, uveítis, eritema nodoso y el fenómeno de patergia (formación de pústula ante pequeños traumatismos cutáneos, por ejemplo al inyectar suero fisiológico en la piel). Como vasculitis, puede afectar SNC, SNP y riñones. El diagnóstico es eminentemente clínico (úlceras + patergia) y no hay ningún marcador específico. El tratamiento para cuadros leves (solo úlceras) es colchicina; en cuadros más graves se usan corticoides más ahorradores de corticoides, y biológicos de última línea.